

Alteraciones neuropsicológicas según territorios vasculares. Infartos corticales.

ARTERIA CEREBRAL ANTERIOR (ACA)

Trastorno atencional.

Cambios de personalidad y estado emocional.

- Trastornos obsesivo-compulsivos.
- Apatía.
- Abulia.
- Desinterés.
- Síndromes prefrontales: orbitofrontal, dorsolateral y ventromedial.

Ansiedad, inquietud, agitación, insomnio, etc.

Funciones premotoras (ritmos, secuencias, alternancias gráficas, coordinación motora, etc.).

Alteración en lenguaje:

- Logorrea.
- Afasia motora transcortical (territorio frontera ACA-ACM).
- Alexia anterior.
- Mutismo transitorio.

Síndromes de desconexión callosa:

- Apraxia miembros izquierdos.
- Agrafía unilateral izquierda.
- Anomia táctil.

Síndrome de utilización.

Oclusión bilateral.

Alteración en personalidad-conducta:

- Apatía.
- Enlentecimiento.
- Abulia cognoscitiva.
- Apatía.
- Falta de espontaneidad.
- Mutismo acinético.

Puede aparecer amnesia aguda con fabulación, en infartos bilaterales o lesiones subcorticales.

ARTERIA CEREBRAL MEDIA (ACM)

Tronco principal:

Hemisferio dominante:

- Alteración nivel conciencia.
- Alteración en lenguaje.
- Afasia global.
- Escritura.

Hemisferio no dominante:

- Heminegligencia izquierda.
- Apraxia constructiva.
- Anosognosia (no reconoce sus déficits).

Tronco superior:

Hemisferio dominante:

- Afasia extrasilviana motora o perisilviana de Broca.

Hemisferio no dominante:

- Anosognosia.
- Heminegligencia espacial.

Tronco inferior:

Hemisferio dominante:

- Alteración en el control motor cognitivo voluntario de gestos y posturas.
- Alteración en secuencias de órdenes.
- Afasias perisilvianas de Wernicke y de conducción.

Hemisferio no dominante:

- Déficit atencional.
- Pérdida de atención del campo visual izquierdo.
- Impersistencia motora.
- Alteración en el vestir.
- Alteración de memoria visual.
- Desorientación topográfica.
- Anosognosia.
- Asomatognosia.
- Déficit en funciones visoperceptivas, visoespaciales y visuoesconstructivas.
- Trastornos visoespaciales en lectura, escritura y cálculo.

Síndrome de Gerstmann (tronco inferior-pliegue curvo):

- Desorientación izquierda-derecha.
- Alteración principalmente en el control motor para la escritura.
- Cálculo alterado.
- No reconoce dedos al tacto.

Síndrome de la circunvolución anular completo (parte posterior de la ACM):

- Afasia fluente.
- Alexia con agrafía.
- Síndrome de Gerstmann.
- Alteraciones constructivas.

ARTERIA CEREBRAL POSTERIOR (ACP)

Hemisferio dominante:

Alteración en lenguaje:

- Afasia sensorial transcortical (también en territorio frontera ACM-ACP).
- Afasia o anomia ópticas.
- Anomia cromática.
- En lectura, por alteraciones perceptivas.

Alteración en memoria verbal.

Hemisferio no dominante:

- Alteraciones graves en percepción visual.
- Alteraciones en funciones visuoespaciales y visuocconstructivas.
- Alteración en reconocimiento de caras y de colores.
- Alucinaciones visuales.
- Palinopsia (persistencia de la imagen presentada al paciente tras su retirada).
- Desorientación espacial.
- Heminegligencia izquierda (territorio frontera ACM-ACP).

Oclusión bilateral:

- Trastorno del curso y contenido del pensamiento con agitación.
- Síndrome de Balint:
 - ♦ Simultanagnosia: sólo percibe partes no un todo; es incapaz de percibir las partes de un espacio como un todo. Desorientación visual.
 - ♦ Ataxia óptica: dificultad para señalar un objetivo; dificultad para alcanzar los estímulos presentados visualmente.
 - ♦ Apraxia oculomotora: mirada desorganizada, errática, sin puntería. Incapaz de cambiar la mirada de un objetivo a otro. Déficit de rastreo visual. También llamada parálisis de la mirada.
 - ♦ Cuadrantanopsia inferior: defectos del campo visual correspondiente al cuadrante inferior. No es un componente excluyente del síndrome.

Anosognosia.

Síndrome de Antón (ceguera cortical con anosognosia): dicen ver cuando en realidad no ven. Se acompaña, a menudo, de alucinaciones visuales.

Alteración en reconocimiento de colores (ceguera) y caras (prosopagnosia).

Alteración grave en memoria.

Alteraciones neuropsicológicas según territorios vasculares. Infartos corticales.